

12 - 05-Le médiastin normal et pathologique - Pr. Mouhsine

Bonjour, cette séance sera consacrée pour traiter un espace anatomique intra-thoracique profond, le médiastin. On verra ensemble l'aspect normal et les aspects radiologiques qui peut prendre cette pathologie, cette zone anatomique. Au cours de cette séance, on verra l'intérêt et la place de chaque technique démarrée dans le diagnostic, la caractérisation et la prise en charge de ces masses ou ces lésions médiastinales.

Les objectifs pédagogiques de ce cours sont conçus. Initialement, connaître la radioanatomie du médiastin et sa subdivision en étages et en compartiments. Également comme objectif, connaître les différents moyens d'imagerie du médiastin, savoir orienter le diagnostic d'une anomalie médiastinale sur un cliché thoracique.

Et enfin, connaître les principales étiologies des masses médiastinales. Cette question trouve son intérêt du fait que le médiastin est une zone anatomique profonde, inaccessible à l'examen clinique et son exploration relève essentiellement de l'imagerie. L'imagerie dans cette zone anatomique offre une approche diagnostique précise.

Cela permet de donner une topographie exacte de certaines lésions, leur nature exacte, l'extension loco-régionale et permet également de guider des éventuels biosyphètes cutanés ou transpalidables. C'est quoi cet espace anatomique ? Le médiastin est un espace situé dans la partie moyenne de la cavité thoracique entre les deux poumons. Ce médiastin est délimité en avant par le sternum et les constituants de la paroi thoracique antérieure, comme les côtes, les muscles et les fascias.

En arrière, il est délimité par le rachis, latéralement par les faces médiastinales des poumons, en haut par le défilé cervicothoracique, limité par le bord supérieur de la première vertèbre dorsale. Les premiers côtés, droite et gauche, et le bord supérieur du manubriant sternal, en bas par le diaphragme. Cet espace contient plusieurs textures, essentiellement le cœur et le gros vaisseau, la trachée et les branches souches, le zoophage, les nerfs pneumogastriques et phréniques récurrents, les chaînes sympathiques, les chaînes ganglionnaires, le thumis qui n'existe qu'à l'état de reliquat chez l'adulte.

La radiographie du thorax est l'examen de première intention pour l'exploration du médiastin. L'incidence de face permet d'affirmer le siège médiastinal d'une anomalie. L'incidence de profil permet de préciser le siège d'une anomalie médiastinale de taille suffisante dans l'un des compartiments du médiastin.

Le scanner ou la tomодensitométrie est l'examen de deuxième intention. C'est un examen clé. Il permet de préciser la topographie exacte de la lésion médiastinale, la nature de la lésion, différencier entre tout ce qui est tussulaire, graisseux, kystique et calcique.

Également, ça permet d'étudier le comportement vasculaire de lésion médiastinale. Ça permet le

bilan d'extension et également de guider certains dossiers transpalatables. L'IRM ou l'imagerie par résonance magnétique trouve un intérêt dans l'étude des masses médiastinales postérieures.

Pour étudier le rapport avec le rachis et le canal rachidien. Également, permet d'étudier l'envahissement du pédécalle, de la masse cardiaque et de la paroi. Et également, ça permet la surveillance des masses résiduelles ou de la fibrose.

Les autres examens trouvent également une place dans certains cas comme l'échographie pour les masses superficielles, le transit oesophagien, l'écho-endoscopique également, l'angiographie, le PET scan et surtout la radiologie interventionnelle écho-scanner guidée pour réaliser certaines biopsies. Concernant la radioanatomie normale sur le cliché thoracique standard de face. Il faut savoir une chose, les organes du médiastin ont une densité hydrique et sont noyés dans le système médiastinal qui a aussi une densité hydrique.

Pour les différencier des étudiés, il faut donc qu'ils soient silhouettés par une substance de densité radiologique différente. Souvent, c'est l'air. Donc, l'air contenu dans le médiastin, essentiellement dans la tracture bronchique, l'air contenu dans les poumons.

En aspiration renforcée, les poumons se moulent sur les organes du médiastin de voisinage et créent des lignes de tangence, les lignes médiastinales qui portent le nom des organes silhouettés. Donc, parfois former les bords du médiastin. Pour le bord droit, on a le tronc veineux brachio-céphalique en haut.

On a la cavité supérieure que vous voyez ici. On a également l'oreillette droite et en partie, en bas, la cavité inférieure. Pour le bord médiastinal gauche, essentiellement formé des textures artérielles.

En haut, on a l'artère sous-clavière gauche. Un peu en bas, on a le bouton aortique marqué ici. On a le tronc de l'artère pulmonaire et l'oreille gauche en bas.

Et on a en bas le ventricule gauche. Les principales lignes médiastinales que vous devez connaître sont. On note la ligne médiastinale postérieure, c'est cette Y de jaune.

Ces bras dépassent en haut le manubrium sternal. Ça correspond à l'adoucement des deux plèvres viscérales en pré-vertébrale. On a également la ligne médiastinale antérieure.

Comme vous voyez, c'est cette ligne orange ou cette Y qui ne dépasse pas en haut le manubrium sternal. Ça correspond à l'adoucement des plèvres viscérales en rétro-sternal. On note également la présence d'une ligne paratrachéale droite.

Également, on a les deux lignes para-vertébrales droite et gauche. Également, on note la ligne para-aortique gauche que vous voyez ici. Et également, assez souvent, on note la présence d'une ligne para-oesophagienne.

On est inversé comme vous voyez sur ce schéma. À peu près sur cette radiographie, ça doit être ça. Donc, pourquoi connaître ces lignes médiastinales ? Tout simplement, tout épaississement, tout rouffouillement ou déformation de ces lignes médiastinales orientent vers la pathologie en question.

Par exemple, déformation de la ligne para-avortique oriente vers la présence d'une lésion vasculaire probablement anabolismale Écartement ou déformation des lignes para-vertébrales orientent vers une pathologie disco-vertébrale. C'est l'intérêt de connaître l'aspect de ces lignes médiastinales. Donc, vous voyez bien sur ce schéma les principales lignes médiastinales que vous devez connaître.

Je vous rappelle la ligne médiastinale postérieure, la ligne médiastinale antérieure, la ligne para-oesophagienne, la ligne para-trachiale, les deux lignes para-vertébrales et la ligne para-avortique. Toute déformation, épaississement ou rouffouillement de ces lignes orientent vers la pathologie en question. Sur ces deux radiographies thoraciques de face, c'est facile d'identifier les principales lignes médiastinales, à savoir la ligne para-trachiale à droite.

Si vous pouvez deviner la présence de lignes para-oesophagiennes, fines lignes opaques réalisant un aspect honnête inversé. Également, vous avez ici, vous pouvez suivre le bouton avortique et l'avort en bas, et vous avez ici la ligne para-avortique. Également, vous pouvez identifier facilement les lignes para-vertébrales à droite et à gauche.

Donc, à titre de rappel, ce médiastin est séparé en trois compartiments. Un compartiment antérieur, un compartiment moyen et un compartiment postérieur. Donc, pour le compartiment antérieur, il est délimité entre un plan frontal passant par le bord postérieur du sternum et un plan frontal passant par le bord antérieur de la trachée et le bord postérieur du cœur.

Le médiastin ou le compartiment postérieur est entre les gouttières costovertébrales et un plan frontal passant à environ un centimètre derrière le bord antérieur du corps vertébraux et le compartiment moyen entre les deux. Également, ce médiastin est séparé en trois étages. Un étage supérieur avortique, un étage inférieur infracardinaire et un étage moyen entre les deux.

Pourquoi? C'est très intéressant de connaître ces divisions anatomiques en compartiments et en étages. Tout simplement, ça permet de donner une localisation exacte de la lésion médiastinale et également la répartition préférentielle des lésions au dépôt de certains compartiments. C'est très intéressant de connaître pour préciser la localisation et la probabilité diagnostique.

Encore une fois, ces deux schémas anatomiques selon un plan axial et un plan sagittal montrent la subdivision anatomique de cet espace anatomique profond en trois compartiments. C'est divisé en compartiments, mais également en trois étages supérieurs, moyens et inférieurs comme vous voyez sur ces schémas selon un plan axial et un autre plan coronal. Sur les coupes axiales de la TDM, les coupes natives, on aura une idée sur l'ensemble des textures qui contiennent

le médiastin.

Les textures vasculaires, la horte ascendante, descendante, la vancave supérieure, la trachée et également les espaces graisseux antérieurs et postérieurs d'adoucissement des plèvres viscérales en antérieur et en postérieur qui réalisent les lignes médiastinales antérieures et postérieures chose qu'on a détaillée dans le chapitre Stémiologie radiologique standard des lignes médiastinales. Vous avez sur cette diapositive des coupes scanographiques réalisées en fenêtré médiastinale Allons défiler celle du cotoracique montrant les textures tiroïdiennes, le paquet gigélocarotidien, jusqu'à la masse cardiaque comme vous voyez ici cette coupe, les différentes cavités cardiaques ainsi que la horte descendante. Sur cette diapositive vous avez des images scanographiques réalisées en fenêtré médiastinale montrant les cavités cardiaques, les cavités droites, oreillette droite, ventricule droite, l'oreillette gauche et ventricule gauche.

Sur cette coupe vous avez ici l'aspect de la horte descendante ainsi que des pieds hydrafragmentifs de part et d'autre. Ici vous avez des coupes scanographiques du médiastin réalisées en fenêtré par un schémateuse. Vous voyez l'aspect de la graisse intramédiastinale surtout.

Une fois qu'on a connu la radioanatomie médiastinale, la sémiologie médiastinale, on passera au syndrome médiastinale. Le syndrome médiastinale se définit comme l'ensemble des signes traduisant une anomalie médiastinale. Il peut s'agir d'opacité, d'hyperclarité ou de classification.

L'opacité médiastinale se définit comme une opacité de tonalité hydrique à limites externes nettes, à limites internes noyées dans le médiastin et il se raccorde en pente douce avec les bords du médiastin. Cette définition est très intéressante à connaître pour faire la part des choses entre opacité médiastinale et opacité par un schémateuse. Pour la localisation, ça passe par l'analyse des bords du médiastin.

A la recherche d'un déplacement, d'une déformation ou d'un effacement d'une ligne médiastinale qui permet de s'orienter vers la localisation de la lésion médiastinale. Donc ça passe également par la recherche des signes sémiologiques à savoir le signe de la silhouette, le signe séducotoracique, le signe de la convergence d'huiles, le signe du recouvrement des huiles et le signe thoraco-abdominal. On verra par la suite la signification de chaque signe.

Je commence par le signe de la silhouette. Devant deux textures de densité égale, en contact, les limites s'effacent. A titre d'exemple, pour une masse paracardiaque droite.

Si on voit que les limites s'effacent entre les deux, ça veut dire que ces deux textures, la masse cardiaque et la lésion, se trouvent dans le même plan. Donc ces textures siègent au niveau du lobe moyen. Alors que si on a une autre lésion en projection paracardiaque droite, et on voit l'interface entre les deux, ça veut dire qu'il y a du parenchyme entre les deux.

Donc ça veut dire que la lésion paracardiaque est une lésion au départ du lobe inférieur droit. Ce

signe de la silhouette est valable pour localiser certaines lésions selon le plan antéro-postérieur. Comme vous voyez, l'exemple d'une lésion qui se situe dans le même plan que le bouton aortique, un plan antérieur.

Alors que pour une autre lésion postérieure, vous voyez bien qu'il y a de l'interface de séparation entre le bord inférieur gauche du cœur et la lésion. Ça veut dire que la lésion est une silhouette parallèle et se trouve dans un plan postérieur. Sur ces radiographies thoraciques de face, on voit la présence d'une lésion de tonalité hédérique en projection paracardiaque.

On voit l'interface de séparation n'est pas silhouettée et face entre les deux. Donc, cette lésion se trouve dans un plan frontal antérieur. Donc, cette lésion dépend du lobe moyen.

Sur ces radiographies thoraciques de face et de profil, on voit bien la présence d'une lésion paracardiaque gauche. Cette lésion est silhouettée parallèle. Donc, c'est une lésion de localisation postérieure, chose que vous confirmez par une incidence de profil.

C'est une lésion postérieure. Ce qu'on a vu était valable pour le signe de la silhouette. On passera au deuxième signe, le signe cellulaire thoracique.

Sur ce schéma, le schéma A que vous avez ici, vous avez une opacité qui n'est pas visible au-dessus de la clavicule. Donc, c'est une opacité noyée dans les structures médicinales antérieures. C'est une opacité antérieure.

Donc, devant toute opacité, on doit suivre son contour externe. S'il ne dépasse pas la clavicule, c'est une lésion antérieure. Alors que sur ce schéma B, vous êtes devant une opacité cervicothoracique.

L'opacité reste visible en-dessus sa claviculaire. L'opacité, donc, elle est postérieure. Sur cette radiographie thoracique de face, on note la présence d'une opacité médicinale cervicothoracique.

Médicinale, pourquoi? C'est une opacité de tonalité hydrique, de contour externe lisse, de contour interne noyée dans le médiastin. C'est une opacité qui reste visible en-dessus sa claviculaire. Donc, c'est une opacité selon le signe cervicothoracique, opacité de localisation postérieure.

Le scanner réalisé sur ce patient confirme la localisation de la lésion antérieurement décrite sur la radiographie thoracique de face. Il s'agit bien d'une lésion médicinale de localisation postérieure qui déborde largement le plan claviculaire. Il s'agissait d'un organome, une lésion nerveuse.

Sur cette radiographie thoracique de face, on note la présence d'une lésion cervicale de tonalité hydrique marquant une empreinte sur la clarté tracheale qui la refoule à droite. Cette lésion est caractérisée par le scanner qui nous montre bien que c'est une lésion médicinale au dépens de la thyroïde. C'était un gouâtre plongeant en notre thoracique.

Afin de donner une topographie, une localisation exacte des lésions médicinales, on a vu l'intérêt des signes de la silhouette. On a vu également l'intérêt des signes cervicothoraciques, donc on passera aux signes de la convergence des îles. Sur le schéma A, les vaisseaux.

Quand on est devant une lésion médiastinale, on voit les vaisseaux. S'ils s'arrêtent sur l'opacité île, comme vous voyez sur ce schéma, il s'agit bien d'une grosse artère pulmonaire. Si les artères sont vues à travers la radiographie thoracique de face, à travers l'opacité, c'est une lésion tumorale.

C'est un signe qui permet de faire la différence entre une artère au lobe de ses branches et une tumeur médiastinale. On se réfère aux vaisseaux de voisinage. Sur ce cliché thoracique de face, on note la présence d'une lésion médiastinale en projection de l'artère pulmonaire.

On va vérifier les vaisseaux de voisinage. On voit bien que les petits vaisseaux s'arrêtent au niveau de l'opacité. Il s'agit vraisemblablement d'une grosse artère pulmonaire.

Cela est confirmé par un scanner qui nous confirme la présence d'une grosse artère pulmonaire, comme vous voyez sur ce groupe scanographique. La lésion qu'on a vue sur la radiographie thoracique de face correspond à une grosse artère pulmonaire. On a vu le signe de la silhouette.

On a vu le signe cervical-thoracique. Également, on a vu le signe de convergence. On passera au signe thoraco-abdominal, ou le signe de l'iceberg, qui correspond au signe cervical-thoracique en haut.

Devant une opacité thoraco-abdominale, si le contour inférieur au externe rejoint le rachis, comme vous voyez sur ce schéma, il s'agit ici d'une masse susdiaphragmatique, de position susdiaphragmatique. Si on suit le contour externe qui traverse le diaphragme, en s'écartant du rachis en distalité, la masse dans ce cas-là est thoraco-abdominale. Sur cette radiographie thoracique de face et les coupes scanographiques correspondantes, cette opacité de siège thoraco-abdominal, si on suit son bord externe en bas, il rejoint le rachis.

Encore confirmé sur ces coupes scanographiques, l'opacité, évidemment, c'est une opacité, ou dépend du rachis, de localisation thoracique. Une autre iconographie d'une opacité de localisation intra-thoracique, comme vous voyez sur cet endroit, une opacité de tonalité aiguë, les bords externes de face et d'autre du rachis rejoint en bas la ligne du rachis. C'est une opacité thoraco-abdominale qui correspond à une spondylose des sites infectieux d'origine tuberculose.

Jusqu'à maintenant, on a vu le signe de la silhouette, le signe séduco-thoracique, le signe thoraco-abdominal ou d'iceberg, on a vu le signe de convergence, on passera au signe de recouvrement illaire. Normalement, l'artère pulmonaire gauche se projette en dehors du bord du médiastin, au ras du bord du médiastin ou au maximum à 1 cm en dedans. Si les ombres vasculaires sont visibles à plus de 1 cm en dedans du bord médiastinal, il s'agit d'une tumeur

médiastinale probable.

Si, au contraire, ça se projette très en dehors, il s'agit bien d'une cardiomygalie ou d'un épongement péricardique. Le schéma suivant explique ce qu'on a déjà vu sur le signe de recouvrement. L'aspect normal, vous voyez que l'huile se projette en paracardiaque ou en paraillaire au maximum 1 cm en dedans, pas plus.

Si ça dépasse, il s'agit bien d'une tumeur médiastinale qui refoule, les textures vasculaires illaires en dedans. Si, au contraire, il se projette en plus en dehors, il s'agit bien d'une cardiomygalie ou d'un épongement péricardique. Donc, je récapitule pour ce signe de recouvrement illaire.

C'est un signe très intéressant pour différencier entre une tumeur médiastinale antérieure au moyen et une cardiomygalie ou un épongement péricardique. Sur cette radiographie thoracique de face, on note la présence d'une volumineuse masse médiastinale qui refoule les vaisseaux illaires en dedans, largement plus de 1 cm en dedans. Il s'agit bien d'une masse tumorale.

Ici, ça correspond à un thymolipome. Sur cette radiographie thoracique de face et la courbe scanographique correspondante, il s'agit d'une opacité de médiastin moyen, encore confirmée et caractérisée par un scanner. Il s'agissait d'un kyste bronchogénique, une lésion mathématique.

Alors que sur cette radiographie thoracique de face et la courbe scanographique correspondante, il s'agit d'une opacité du médiastin antérieur. Il s'agissait d'un thymol. On a terminé par les tumeurs médiastinales ou les masses médiastinales.

On passera aux hyperclartés médiastinales. Ces hyperclartés peuvent être digestifs, soit de l'air oesophagien dans le cadre d'un méga oesophage, des ventricules hauts, des hernies et atales comme vous voyez sur cette radiographie thoracique de face. La présence de l'air en rétrocardia qui correspond vraisemblablement à une hernie atale.

Également, ça peut être du pneumopélécate, de l'air entre le feuillet viscéral et le feuillet palatal de ce pécate. Ici, radiographie thoracique de face qui nous montre la présence d'une structure qui contient de l'air et de liquide avec niveau hydroaérique qui correspond à un méga oesophage. Les hyperclartés médiastinales peuvent être de l'air digestif, de pneumopélécate comme ça peut être de pneumomédiastin, c'est de l'air dans le médiastin.

Les signes radiologiques s'observent sous forme de fines clartés linéaires intramédiastinales délimitées en dehors par la plèvre. Il faut devant ces signes rechercher un enfysème parital associé. Ce qu'on a vu sur ces lignes de clartés intramédiastinales, on peut les confirmer par un scanner aux fenêtres par angiomoteuse.

Ce qui est hyper clair c'est de l'air à l'intérieur du médiastin. Les causes sont différentes, ça peut être idiopathique sans cause évidente comme ça peut être d'origine traumatique, iatrogène ou de l'asthme. Mais devant ce pneumomédiastin sans cause ou sans idéologie évidente, il faut

chercher des lésions enfysémoteuses du parenchyme pulmonaire en regard.

Ces radiographies thoraciques de face nous montrent la présence de l'air intramédiastinal en faveur d'un pneumomédiastin. Ces coupes scanographiques aux fenêtres parangiomoteuse nous montrent la présence d'un pneumomédiastin si associé à l'enfysème parital qui atteste l'origine traumatique de ce pneumomédiastin. On a vu les masses médiastinales, les perceptions médiastinales.

On verra les calcifications médiastinales qui peuvent être vasculaires, essentiellement les calcifications aortiques. Ils peuvent être cardiaques, vasculaires ou péricardiques. Ils peuvent être ganglionnaires, surtout dans le cadre de la tuberculose, la silicose, la sarcoïdose, ou certaines tumeurs comme le thymome, le goitre et le thératome.

Les coupes scanographiques aux fenêtres médiastinales sans injection de produits de contraste nous montrent la présence de calcifications ganglionnaires et bilatérales et symétriques dans le cadre d'une sarcoïdose. Une fois qu'on a connu les signes sémiologiques de ce syndrome médiastinal, que ce soit l'opacité tumorale, l'hyperclarté intramédiastinale ou la calcification, on passera au chapitre étiologique. Quels sont ces étiologies? Principalement, on est devant des adénopathies médiastinales.

Ce sont des opacités fréquentes et nuquées aux multiples polycycliques. Le plus petit diamètre est supérieur à 1 cm pour parler d'adénopathie, alors que moins de ce chiffre, c'est un ganglion. A noter qu'aucun moyen d'imagerie actuel ne permet d'approcher la nature de l'adénopathie, maligne ou bénigne.

Ce n'est pas la notion de la taille. La notion de la taille peut orienter, mais ce n'est pas suffisant pour s'orienter vers sa nature maligne ou bénigne. Cette radiographie thoracique de face que vous voyez ici nous montre la présence des adénopathies parailières et interbranchiques bilatérales dans le cadre de la sarcoïdose.

Il faut connaître que certaines associations radiologiques sont évocatrices. Les adénopathies hilaires bilatérales et latérotraquiales inférieures droites non compressives orientent vers la sarcoïdose, doivent évoquer la sarcoïdose en première intention. Les adénopathies médiastinales antérieures et latérotraquiales droites orientent vers la maladie de Hodgkin.

Les adénopathies nécrosées orientent vers la tuberculose, les métastases ou les lymphomes. Les adénopathies capsifiées orientent également vers la sarcoïdose, la silicose, la sarcoïdose et la mylose. Sur cette iconographie radiothoracique de face, on note la présence d'opacités hilaires bilatérales qui correspondent à des adénopathies dans le cadre de la sarcoïdose.

Sur cette iconographie thoracique de face, on note la présence de volumineuses opacités ou d'adénopathies pendant l'aspect encheminé en rapport avec un lymphome. Sur cette coupe scanographique fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on note la

présence de plusieurs adénopathies médiastinales dans un cadre métastatique ou d'organisation secondaire. Sur cette courbe scanographique fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on note la présence de plusieurs adénopathies nécrosées dans le cadre de la tuberculose.

Sur cette courbe scanographique fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on note la présence de plusieurs adénopathies nécrosées dans le cadre de la tuberculose. Pour le médiastin moyen, il est intéressé essentiellement par les adénopathies et l'équiste bronchogénique. L'équiste bronchogénique représente 10% de l'ensemble des tumeurs du médiastin du siège latérotraquial sous-carinaire, qui se caractérise par l'absence de rayonnement après injection de produits de contraste, ce qui permet souvent d'en faire le diagnostic positif de ces lésions malformatives.

Comme vous le voyez sur cette radiographie thoracique de RAS, la présence d'une masse médiastinale paratraquiale, refoulant la trachée vers le côté gauche, encore confirmée par le scanner, est reconnue par les tumeurs médiastinales après injection de produits de contraste, qui nous montre la présence d'une lésion de densité liquidienne épaisse, refoulant les stressures traquiales et la carène, qui correspond vraisemblablement à l'équiste bronchogénique. On a vu les différentes histiologies du médiastin antérieur, du médiastin moyen. On arrive au médiastin postérieur, intéressé essentiellement par les tumeurs nerveuses, ce sont les principales tumeurs qui intéressent ce compartiment.

Ces lésions se caractérisent par le faible rayonnement après injection de produits de contraste, et dans ce cas-là, dans cette localisation, l'IRM est indiqué à la recherche d'un prolongement intra-rachidien. Toujours dans le médiastin postérieur, on peut avoir des traumatismes. On peut avoir des atteintes vertébrales lors de certaines tumeurs ou de certaines lésions infectieuses, comme la spondylo-dysythe, comme on peut avoir des mélingocelles qui restent rares, le diagnostic est porté souvent par l'IRM, ou même on peut avoir de l'hématopoïse extra-modulaire, comme vous voyez sur cette courbe scanographique, la présence de l'hématopoïse de lésion para-vertébrale qui correspond à de l'hématopoïse extra-modulaire.

Cette iconographie nous montre la présence des hyperclarités intramédicinales qui s'associent à de l'amphidémie succitanée, ce qui oriente vers la nature traumatique de ce pneumo-médiastin. Sur ce tissu thoracique de face, on note le refoulement de la ligne para-aortique qui oriente vers une déformation de l'axe aortique, ça correspond vraisemblablement à une lésion anéblismale de l'aorte. L'anéblisme de l'aorte est confirmé sur ces courbes scanographiques réalisées entre les intramédicinales après injection de produits de contraste, il s'agit bien d'un anéblisme de l'aorte descendante.

Sur ces courbes scanographiques, on note la présence de coulées ganglionnaires, de coulées nécrotiques et des magmas d'adénopathie intramédecine. En guise de conclusion, L'exploration de la pathologie médiastinale se base essentiellement et initialement sur la radiographie

thoracique de face. C'est l'examen de première intention à demander devant toute suspicion de masse ou de lésion médiastinale.

La tomodensitométrie ou le scanner est un examen complémentaire essentiel pour l'approche du diagnostic positif parfois, le diagnostic étiologique et le bilan d'extension, mais également pour réaliser certaines lésions, certaines biopsies scanner guidées. L'imagerie par résonance magnétique est surtout utile pour l'étude des masses médiastinales postérieures, essentiellement les lésions nerveuses envahissant le rachis cervical-dorsal. Merci pour votre attention.

A la prochaine séance.